

12 - 02- Les gastrites - Pr. Samlani

Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des gastrites. Le terme gastrite est un terme qui est utilisé à tort et à travers, un peu colmaté. Souvent le patient, se plaignant de douleur épigastrique, viendra vous voir et vous sortira le terme gastrite.

Parfois, c'est l'endoscopiste qui va parler de lésions évoquant une gastrite sur un aspect endoscopique particulier. Mais c'est l'anapath qui peut poser le diagnostic de gastrite en montrant une atteinte inflammatoire de la muqueuse gastrique. Les gastrites sont fréquentes et la principale cause est l'*Helicobacter pylori*.

Le diagnostic repose, comme je viens de le dire, sur des biopsies avec études anapathes montrant le caractère inflammatoire. A part l'inconfort ressenti par le patient, la douleur, le risque majeur de ces lésions et l'évolution à des pathologies graves, notamment l'ulcère, l'adénocarcinome et le lympho. Sur cette diapositive, vous avez le rappel anatomique de base de l'estomac avec l'œsophage, la partie inférieure, le cardiaque, la partie verticale de l'estomac et l'entree.

La particularité des gastrites chroniques, c'est qu'elles ont un infiltrat anormalement dense de cellules inflammatoires dans le corion de la muqueuse. Le risque de ces gastrites, c'est que certaines deviennent atrophiées, c'est-à-dire qu'elles occasionnent une atrophie des glandes gastriques. Et ce sont celles-ci qui peuvent évoluer vers les maladies graves, vers le cancer.

Et il y a d'autres gastrites qui ne sont pas atrophiées. Est-ce que l'évolution vers le cancer gastrique est inéluctable ? Cela veut dire, est-ce qu'une gastrite chronique égale à 100% un cancer gastrique ? Vous voyez sur cette diapositive que pour 100 sujets qui ont une gastrite chronique active, 50 vont développer une atrophie glandulaire, 40 une métaplasie, 8 une dysplasie et 1 sujet un cancer gastrique. Ceci veut dire que gastrite chronique active ne veut pas dire à 100% cancer gastrique.

Cependant, ce sont des sujets qu'il faudra traiter et par la suite bien sûr surveiller. La gastrite atrophiée à *Helicobacter pylori* peut également être responsable du lymphome de MALT, qui est le lymphome associé au tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Alors comment se manifeste cliniquement la gastrite à *Helicobacter pylori* ? En l'absence de lésions ulcéreuses ou tumorales associées, souvent ce sont des gastrites asymptomatiques ou des sujets asymptomatiques.

Ils peuvent avoir des troubles dyspeptiques ou assimiler une dyspepsie comme on a vu dans le cours de la dyspepsie. Et le diagnostic sera posé à l'endoscopie avec biopsie et bien sûr à l'anapathie. Ce sont des sujets qu'il faudra traiter et bien sûr éradiquer *Helicobacter pylori*.

Deuxième type de gastrites chroniques, ce sont les gastrites auto-immunes. Elles sont rares, généralement se reviennent chez des femmes de plus de 50 ans. Et ce sont des gastrites qui sont limitées au corps, responsables d'un infiltrat lymphoplasmocytaire avec une atrophie des

glandes au niveau du fundus.

Il faut savoir que ce sont des gastrites qui surviennent dans un terrain d'auto-immunité. Ce sont des patients chez qui il faut rechercher un diabète, une thyroïdite, des lésions cutanées comme un vitiligo. Et *Helicobacter pylori* n'est en aucun cas responsable de ces gastrites auto-immunes.

Cliniquement, elles vont aussi être asymptomatiques ou bien avec très peu de signes spécifiques. Du fait qu'elles touchent la partie verticale de l'estomac, il y a une absence de fabrication, de sécrétion de facteurs intrinsèques. Le facteur intrinsèque, comme vous le savez, est important pour l'absorption de la vitamine B12 au niveau des léons.

Et donc cette absence de sécrétion, de synthèse de facteurs intrinsèques va être responsable d'une malabsorption de vitamine B12. Elle-même responsable d'une anémie macrocytaire régénérative dite pernicieuse, d'une glossite ou bien de signes neurologiques tels qu'une sclérose combinée de la moelle. Le diagnostic, là aussi, sera fait par la recherche de ces éléments d'auto-immunité, les anticorps sériques anticelluloparietal et les anticorps antifacteurs intrinsèques.

Pour l'évolution de ces gastrites auto-immunes, 20% vont évoluer vers une anémie de Birmer, d'autres vont évoluer vers des tumeurs carcinoïdes fendiques. Et le risque relatif est de 3 pour le développement d'un adénocarcinome gastrique. Donc les gastrites auto-immunes peuvent également évoluer vers des adénocarcinomes, mais aussi vers d'autres formes de tumeurs, tels que les tumeurs carcinoïdes fendiques, ce qui justifie bien sûr la surveillance de ces patients.

Alors quelle surveillance, quel traitement pour ces lésions ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il faut prévenir ou corriger la carence en vitamine B12 par une injection musculaire, intramusculaire mensuelle de vitamine B12. Et ce sont des patients chez qui va falloir instaurer une surveillance endoscopique tous les 3 ans, de manière régulière, avec des biopsies à la recherche, bien sûr, d'une dégénérescence. Donc nous avons vu les gastrites atrophiantes à *Helicobacter pylori*, les gastrites auto-immunes.

Maintenant, les gastrites chroniques qui n'évoluent pas vers l'atrophie. La première, c'est la gastrite chronique lymphocytaire. Et comme son nom l'indique, elle est associée à une présence anormalement élevée de lymphocytes dans l'épithélium de surface et des cryptes, avec bien sûr un infiltrat inflammatoire dans la muqueuse.

Le plus souvent, celles-ci aussi sont asymptomatiques. Elles peuvent être associées à une maladie céliaque dans un tiers des cas, ou bien être tout simplement d'origine indéterminée. Deuxième type de gastrite, ce sont les gastrites granulomateuses.

Celles-ci se distinguent par la présence dans le corion de granulome épithéloïde et gigantocellulaire. La cause est fréquemment identifiée, et on dit dans ce cas-là que la gastrite granulomateuse est idiopathique. Sinon, parfois ce sont d'autres causes, telles que la maladie de

Crohn, la sarcoïdose, certains agents bactériens responsables de granulome, tels que la tuberculose, la syphilis, certains agents parasitaires, des agents mycotiques, ou bien tout simplement la présence d'un corps étranger.

Autre type de gastrite non atrophiant, ce sont les gastrites diosinophiles. Là aussi, comme leur nom l'indique, ce sont des gastrites qui se distinguent par une infiltration à pôle nucléaire diosinophile de la paroi gastrique, et souvent est en cause d'une parasitose, ou dans le cadre de ce qu'on appelle une gastroenterite diosinophile. Après avoir vu les gastrites chroniques, on parlera rapidement des gastrites aiguës.

Helicobacter pylori peut donner des gastrites aiguës qui peuvent évoluer vers la gastrite chronique. La forme aiguë, là aussi, peut se manifester immédiatement après contamination orale par le germe. Elle peut être tout simplement asymptomatique, comme elle peut être responsable d'un tableau non spécifique, avec douleurs épigastriques, des nausées et des vomissements.

Endoscopiquement, c'est-à-dire à la fibroscopie digestive haute, les lésions prédominent au niveau de l'entre. La muqueuse hérimématique est édematisée, siège d'œdème. Nodulaire, ça veut dire qu'il y a des nodules, avec des lésions pétiolées, érosives ou ulcéronécrotiques.

Le diagnostic repose sur la présence de *Helicobacter pylori* à la biopsie, avec une inflammation de la muqueuse, qui est floride, riche en polymorphonucléaires, et il peut y avoir une régression en cas d'éradication. En l'absence de traitement, l'évolution est habituelle vers la chronicité. Autre type de gastrite aiguë, c'est la gastrite phlegmoneuse.

Phlegmoneuse, comme phlegmon. C'est une gastrite qui est exceptionnelle. Souvent, elle est associée à une infection bactérienne sévère, qui va se développer et prendre toute l'épaisseur de la paroi gastrique.

Et souvent, c'est sur un terrain immunodéprimé, que ce soit par une infection rétrovirale au stade SIDA, que ce soit par des médicaments avec une chimiothérapie ou des immunosuppresseurs. C'est dans ce contexte-là que la gastrite phlegmoneuse peut se développer. Autre type de gastrite aiguë, ce sont les gastrites virales, à cytomégalovirus ou à herpèsvirus.

Et là aussi, ce sont aussi des sujets qui sont immunodéprimés. Alors, quelles sont les diagnostics différentiels des gastrites ? Ce sont essentiellement les gastropathies. Les gastropathies sont des affections diffuses de la muqueuse gastrique, mais sans infiltrat inflammatoire.

Donc, on va distinguer des gastrites qui, elles, contiennent bien sûr un infiltrat inflammatoire. Parmi les gastropathies, on reconnaît la gastropathie d'hypertension portale. C'est dans le cadre d'une hypertension portale que le sujet peut présenter des épigastries.

Et le diagnostic endoscopique montrera un aspect en mosaïque, la muqueuse finit, la muqueuse fine,

pétéchiale, avec parfois des varices cardiotubérositaires et bien sûr l'association des varices oesophagiens. La maladie de Manérier est une gastropathie qui est rare, qui se manifeste par un épaissement de la muqueuse findique. Elle est appelée également gastropathie hypertrophique géante.

La symptomatologie digestive n'a rien de spécifique. Elle va se manifester par une exudation protéique anormale par l'estomac, avec un amérissement des œdèmes des membres inférieurs. Elle peut se compliquer aussi d'hémorragie et bien sûr de cancer.

Le diagnostic repose sur l'endoscopie qui va montrer des gros plis findiques, d'aspects différents comme cerveau, et qui permettra donc cette endoscopie de faire des biopsies et de poser le diagnostic. Parfois on a recours à un examen endoscopique plus poussé qu'on appelle échoendoscopie pour montrer un épaissement de la muqueuse. Le diagnostic histologique de la maïs de Maitrié repose donc sur la biopsie, essentiellement sur des biopsies qui sont importantes dites macrobiopsies.

L'évolution de cette maladie et le risque de transformation adénocarcinomateuse comme je l'ai dit. Son traitement n'est pas codifié. Il peut reposer sur un traitement antisécrétoire au long cours et pour les formes sévères ou quand il y a suspicion de gènescence de la gastrectomie.

Autre gastropathie, c'est la gastropathie dans le cadre du syndrome de Zollinger et Lyssen. Il s'agit d'une hypertrophie des plis du findus liée à l'hyperplasie des glandes findiques sous l'effet trophique de l'hypergastrinémie d'origine tumorale quand il y a un gastrinome. C'est-à-dire qu'il y a une tumeur quelque part qui s'écrite de la gastrine et cette gastrine sera responsable d'une hypergastrinémie qui va entraîner une hyperplasie des glandes findiques.

Autre gastropathie, c'est la gastropathie radique post radiothérapie. Elle survient généralement après irradiation gastrique de moins 45°C et elle peut être aiguë avec parfois des oedèmes, des érosions hémorragiques d'évolution généralement favorable en quelques semaines. Au-delà de six mois, on rentre dans la chronicité et on peut retrouver en post radique des ulcérations, des telangiectasies hémorragiques et c'est la biopsie qui va poser le caractère radique.

Dans ce cas particulier, si la tumeur primitive était gastrique, il faut multiplier les biopsies, être vigilant pour éliminer une récurrence tumorale. Après cette explication, je vous montrerai des images endoscopiques de tout ce que je viens de vous dire. Ceci est un estomac normal.

Regardez l'aspect en fond d'œil. C'est une muqueuse qui est rosée en fond d'œil. Là, vous voyez un aspect endoscopique de gastrite atrophique.

Vous voyez que la muqueuse, les oedèmes aciers, elle est brillante et surtout, vous remarquez qu'on voit très bien la vascularisation de l'estomac, ce qui témoigne d'un amincissement de la muqueuse gastrique. Ici, vous avez une gastrite érosive. Regardez bien, il y a des érosions.

C'est l'aspect dont je vous ai parlé au cours de certaines gastrites qui sont virales. Un autre aspect de gastrite érosive. On voit des exulcérations avec quelque chose de noir au fond qui peut s'apparenter à de la nécrose.

Je vous ai parlé tout à l'heure de lésions nodulaires ou micronodulaires. Regardez bien la surface de l'estomac et vous voyez des micronodules. Ce sont des irrégularités.

C'est l'aspect qu'on remarque au cours de la gastrite *helicobacter pylori*. Vous voyez sur cette diapositive une gastropathie d'hypertension portale. J'ai bien barré le terme gastrite.

C'est une gastropathie en mosaïque. C'est surtout pour que vous voyez l'aspect en mosaïque coloré de différentes colorations de la muqueuse gastrique. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle un aspect de gastrite vario-diforme.

Vous avez des lésions pseudo-vésiculaires et qu'on peut retrouver au cours de certaines gastrites virales. La métaplasie intestinale, qui est l'évolution au cours des gastrites atrophiantes, peut se manifester par un aspect en vert dépoli. C'est cet aspect que vous voyez ici.

Blanchâtre avec disparition de cette coloration rosée de l'estomac. Avec disparition de cet aspect qui est normal, qu'on a vu dans l'estomac normal. Et là, je vous mets une image d'une maladie de Menestrier.

Vous voyez les plis, comme ils sont énormes, avec un aspect serré-pli-fin. En conclusion, on distingue les gastrites chroniques des gastrites aiguës. Le principal différentiel, ce sont les gastropathies, qui ne sont en aucun cas des gastrites.

Les gastrites se définissent par la présence d'un infiltrat anormalement dense de cellules inflammatoires dans le corion de la muqueuse. Les gastrites chroniques peuvent être soit atrophiantes, et la principale étiologie en est *Helicobacter pylori*. Dans ce cas-là, la crainte, c'est l'évolution vers la métaplasie, la dysplasie et le cancer.

Ou bien, des gastrites ne l'atrophiantes.